

採血 <後編>

☆Alb（アルブミン）

基準値：3.5 以上(g/dL)

血液中に含まれるたんぱく質。栄養状態の指標として使う。

☆P（リン）

基準値：3.5～6.0(mg/dL)

腎不全では P が尿中に排泄されないため高値になる。

高 P 血症が続くと、

- ・骨折
- ・異所性石灰化（動脈硬化）

の原因となる。

☆Ca（カルシウム）

基準値：補正 Ca 8.4～10.0(mg/dL)

補正 Ca = $\text{Ca} + (4.0 - \text{Alb})$

Ca は Alb と結合しており、Alb 低値の場合 Ca が低値となるため補正 Ca を用いる。

腎不全ではビタミン D が活性化されず、低 Ca 血症になる。

→ビタミン D 製剤：カルシトリオール

☆intact-PTH (インタクト PTH)

基準値：60～300(pg/mL)

PTH→パラソルモン=副甲状腺ホルモン

高 P 血症と低 Ca 血症により PTH が上昇する。

PTH は骨から血中に Ca を放出するため、骨がスカスカになってしまう（骨折の原因）。

→PTH を下げる薬：パーサビブ・ウパシタ

☆K (カリウム)

基準値：3.5～5.5(mEq/L)

果物・生野菜・豆類に多く含まれる。

高 K 血症の症状

- ・四肢、口唇のしびれ
- ・筋脱力感
- ・悪心、嘔吐などの胃腸症状

高 K 血症では不正脈が起こり重篤な場合、心停止。

モニター心電図では P 波消失、徐脈をみとめ、重篤な場合 T 波増高。

☆ β 2-MG（ベータ2-ミクログロブリン）

基準値：30（mg/dL）以下

高値では透析アミロイドーシスの原因となる。

オンラインHDFに切り替えることにより大分子の β 2-MGが除去される。

☆血糖値（透析前血糖値≡食後約2時間後血糖値）

基準値：180～200（mg/dl）

☆GA（グリコアルブミン）

基準値：24.0（%）未満

Albと結合した糖。

過去2～4週間の平均血糖状態を表す。

※透析患者は血糖管理に血糖値とGAを用いる。HbA1cは参考程度。

理由

HbA1cはHbと結合している糖。

- ・赤血球寿命の短絡（60日）→通常は120日
- ・透析による失血や出血（回路内残血など）
- ・エリスロポエチン製剤による幼弱赤血球の増加

これらの要因によってHbA1cが見かけ上低値に出るため、過小評価につながる。

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。